

Historial de Salud 2026 — Eunice Estela López Suárez

CC 1140836476 | 35 años | Medellín, Colombia

Documento actualizado: 21 de junio de 2026

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

- Hernioplastia umbilical
- Cirugía láser ocular
- Tubectomía (2023)
- Legrado uterino (2017)
- Fractura de tibia y peroné derecho (niñez)
- Bursitis patelar izquierda a los 22 años (peso muerto mal ejecutado)

Ciclos menstruales: 4 días / cada 28 días. Eumenorrea. Menarquia a los 9 años.

DICIEMBRE 2025 — Antecedente imagenológico

26 de diciembre — RX panorámica miembros inferiores (Osteomedical)

Radiografía panorámica de miembros inferiores que confirmó **lateralización bilateral de rótulas**. Este hallazgo fue el punto de partida para buscar evaluación especializada de fisiatra.

ENERO 2026

6 de enero — Fisiatra Dra. María Victoria Morales Vergara (Bioforma S.A. Medicina Especializada)

Primera consulta por dolor crónico en rodillas y columna.

Eunice consultó por dolor en rodillas con crepitación (de varios años de evolución) y dolor dorso-lumbar. Se tomaron radiografías en consulta:

- **Columna total:** leve escoliosis postural sin componente rotacional (había sido diagnosticada previamente con 12 grados y trató 3 meses)
- **Rodillas:** lateralización bilateral de rótulas + agudización de espinas tibiales (confirmando el RX de diciembre)

Al examen físico se encontró: inflamación de tendones pata de ganso, puntos de contractura en temporales, ATM y esplenios asociados a bruxismo, y dolor en sacroilíacas. Sin trastorno de movilidad.

Diagnóstico: M624 Contractura muscular + M545 Lumbago no especificado

Plan: Terapia física orofacial y cervical (5 sesiones) + Colchicina 0.5mg por 10 días

6 de enero — Wellness EpixLife

Evaluación de bienestar complementaria. Se identificaron necesidades nutricionales prioritarias: antioxidantes (selenio, alfa-lipoico, sulforafano, polifenoles), minerales (cromo, molibdeno, silicio, selenio) y aminoácidos (valina, alanina, isoleucina, triptófano). Sistemas prioritarios: inmune e intestinal. Se indicó evitar por 90 días: cerdo, centeno, sandía, mora roja, aceite de girasol, cacahuètes, brotes de soja y grosellas.

23 de enero — Ginecología Dra. Deymi Katiuska Nuñez Ávila (Virgen de Coromoto)

Consulta de chequeo general ginecológico.

Se realizó ecografía transvaginal que reveló **miomatosis uterina múltiple FIGO 5-6**: mioma en cara anterior ~32mm y en fondo uterino ~77mm. Útero de 138cc. El informe señaló que no se descarta endometriosis ni EPI. Fue el primer hallazgo formal de los miomas.

Laboratorios tomados ese día:

- FSH: **1.0 mUI/mL** — por debajo del rango luteínica (1.79–5.12) — BAJO
- LH: 1.28 — límite inferior
- TSH: 1.34 — normal
- VIH 1 y 2: Negativo
- Hepatitis B Ag HBs: Negativo

- VDRL: No reactivo

26 de enero — Citología cervicouterina (Citofemme IPS S.A.S.)

Resultado: negativa para lesión intraepitelial y malignidad (Sistema Bethesda 2001). VPH no detectable (dic 2024). Exudado inflamatorio leve. Cuello sano.

Laboratorio adicional ese día — Creatinina en suero: 0.91 mg/dL — marcada con asterisco por estar sobre el rango femenino (0.46–0.83 mg/dL). Requiere monitoreo.

FEBRERO 2026

13 de febrero — TAC abdomen y pelvis con contraste (Ginecología)

Ordenado por la Dra. Nuñez para dimensionar la miomatosis confirmada en enero. Resultados:

- **Mioma exofítico en fundus anterior: 87mm** — el más grande y el de mayor relevancia clínica
- Miomas intramurales adicionales de hasta 29mm
- **Colelitiasis** (cálculos en vesícula) sin signos de colecistitis activa
- Ovarios de aspecto normal

Este TAC es la imagen de referencia más reciente del fibroma principal. A junio 2026 han pasado 4 meses sin imagen de control — **eco transvaginal de seguimiento pendiente y urgente.**

19 de febrero — Seguimiento Fisiatra Dra. María Victoria Morales (Bioforma S.A.)

Segunda consulta de control.

Evolución positiva: los puntos de contractura en zona cervical y dorsal habían desaparecido. Quedaban únicamente puntos gatillo en temporales, ATM y maseteros del lado derecho (zona oral, asociada al bruxismo). Eunice reportó mejoría en el sueño y practicaba consciencia de relajación orofacial.

Diagnóstico: M624 Contractura muscular

Indicación: Continuar hábitos establecidos. Revisión en 2 meses.

JUNIO 2026

3 de junio — YOU Regenerative Medicine — Dra. Luisa María Mejía Arboleda (El Poblado)

Consulta integral de medicina funcional — la más completa hasta la fecha.

Eunice llegó con los siguientes síntomas activos: dolor cervical y bruxismo, dolor dorsal y lumbar, dolor en rodillas, distensión abdominal con gases y presencia de granos, spotting ~7 días antes del período, dispareunia, nicturia y caída de cabello (atribuida inicialmente al cloro de la piscina).

Estilo de vida al momento: Dieta vegana ~7 meses. Entrenamiento de fuerza 3 veces por semana (había reducido de 5–6). Había suspendido la natación por la caída de cabello. Duerme desde las 8pm, despierta ~3am en modo productivo.

Al examen físico: **respuesta pupilar fluctuante** — sugiere alteración del sistema nervioso autónomo y baja tolerancia al estrés.

Diagnóstico: R53X Malestar y fatiga + R522 Otro dolor crónico

Fórmula médica (04/06/2026):

#	Suplemento	Indicación
1	Proteína vegana aislada arveja+arroz 25–30g/día	Meta 115g proteína/día
2	Complejo B metilado (Homocysteine Nutrients)	Mañana
3	Vitamina D3 + K2	Almuerzo, 12 semanas
4	Omega 3 vegano algas DHA+EPA 500–1000mg	Almuerzo
5	Magnesio glicinato 300mg	Noche

#	Suplemento	Indicación
6	Glicina 3g	Noche (junto con magnesio)
7	Creatina monohidratada 3g	Con proteína o almuerzo
8	Probiótico (Probiessens o Plucbiotic)	90 días
9	P-Cide Nutrabiatics 4–8 gotas	Mañana y noche, 2 botellas
10	Vitamina C 500mg	Desayuno/almuerzo, 8 semanas

Suspender: tierra de diatomeas, cromo picolinato (hasta confirmar HbA1c/HOMA-IR), extracto semilla de uva, aceite de orégano (mientras dure P-Cide).

La Dra. Mejía también entregó cotización para **células mesenquimales de cordón umbilical (25–50 millones) en cada rodilla** como opción regenerativa para las articulaciones. Control indicado en 4–8 semanas.

9 de junio — Clínica Metco — InBody 270 + Nutricionista

Consulta por peso estancado.

InBody 270 — composición corporal:

Parámetro	Valor	Estado
Peso	83.8 kg	Alto (+8.3 kg del ideal 75.5 kg)
Masa muscular	32.2 kg	Normal
Masa grasa	25.7 kg	Alto
% Grasa corporal	30.7%	ALTO
Relación cintura-cadera	0.98	ALTO (normal mujer <0.85)
Grasa visceral	Nivel 10	Límite
Metabolismo basal	1,914 kcal	—
Score InBody	80/100	Bueno

Consulta con nutricionista: Propuso quemadores (suplementos termogénicos), uso de faja y masajes de mesoterapia, advirtiéndole que estos últimos dolerían. **Eunice rechazó ese enfoque.** Lo que sí adoptó fue aumentar la ingesta calórica, especialmente proteína, para romper el estancamiento metabólico — recomendación que coincidió con lo que después formalizó la Dra. Mejía en YOU con la meta de 115g de proteína diaria.

11 de junio — Laboratorio POCTLAB — Panel de sangre en ayunas

Examen	Resultado	Rango	Estado
Glucosa	74.9 mg/dL	70–100	Normal
Insulina	4.93 µU/mL	1.9–23	Normal
HOMA-IR (calculado)	0.91	<2.0 normal	Óptimo — sin resistencia insulínica
T4 libre	0.96 ng/dL	0.61–1.12	Normal
T3 libre	3.05 pg/mL	2.5–3.9	Normal
Vitamina D 25-OH	27.75 ng/mL	30–100	INSUFICIENTE
Ferritina	78.60 ng/mL	11–306.8	Normal (límite inferior funcional)
Vitamina B12	195.4 pg/mL	180–914	Técnicamente suficiente pero límite bajo para vegana

Interpretación:

- **Resistencia insulínica descartada** — HOMA-IR 0.91 es óptimo. El origen hormonal de los miomas se debe confirmar con estradiol + progesterona en día 21 del ciclo
- **Tiroides normal en toda la cadena** — TSH (ene) + T4 libre + T3 libre dentro de rango. Falta Anti-TPO para descartar Hashimoto

- **Vitamina D insuficiente** — 27.75 ng/mL. Nivel óptimo funcional para su perfil: 60–80 ng/mL. Hay evidencia de que la vitamina D inhibe crecimiento de fibromas. La D3+K2 recetada era necesaria
- **B12 en zona de alerta** — 195.4 pg/mL. Óptimo funcional para vegana: >300. Las reservas hepáticas siguen agotándose sin suplementación activa
- **Ferritina normal** — descarta anemia ferropénica como causa de caída de cabello
- **Caída de cabello:** causas activas = vitamina D insuficiente + B12 límite + estrés crónico (telogen effluvium). Zinc aún sin medir

DIMENSIÓN EMOCIONAL Y TERAPÉUTICA (2026)

- **Terapia con Ester** — proceso de varios años, en curso
- **Formación en constelaciones familiares** — 2026, con impacto significativo reportado
- **Biodescodificación** — sesión realizada en 2026
- **Audio de Ester (03/06/2026):** "La escoliosis es carga y desesperanza. En la contracción el cuerpo se desarticula. Cada día: respira y mándale a los huesos. Yoga y meditación."

La conexión mente-cuerpo ha sido confirmada de forma independiente por la fisiatra, la médica funcional, la terapeuta y la biodescodificación: el sistema nervioso autónomo en hiperactivación crónica amplifica la inflamación sistémica y contribuye al cuadro completo.

PROTOCOLO ACTIVO — iniciado 10 de junio de 2026

Respiración diafragmática diaria: 10 minutos cada mañana antes de revisar el celular.

Técnica: inhala 4s → retén 4s → exhala 6s. Activa el nervio vago para regular el sistema nervioso simpático.

COTIZACIÓN PENDIENTE — YOU Regenerative Medicine (rodillas)

Plan	Precio	Incluye
Essential Recovery	\$14,700,000 COP	25M células madre por rodilla + ortopedista + seguimiento 6 meses
Advanced Regeneration	\$24,390,000 COP	+ sueroterapia desinflamatoria 3 sesiones + 50M células madre + exosomas
Signature Regeneration	\$26,150,000 COP	Todo lo anterior + 8 sesiones cámara hiperbárica O2 100%

Decisión pendiente hasta después de la cita con el endocrinólogo. Antes de iniciar cualquier terapia IV deben ser informados de los fibromas activos para ajustar el protocolo.

ESTADO ACTUAL Y PRÓXIMOS PASOS (junio 2026)

Resuelto hasta ahora

- Sin resistencia insulínica (HOMA-IR 0.91)
- Tiroides funciona correctamente en toda la cadena
- Citología negativa, VPH negativo
- Contracturas musculares en gran parte resueltas
- Caída de cabello: no es por anemia ferropénica

Pendiente urgente

1. **Eco transvaginal de control** — última imagen del fibroma de 87mm fue febrero 2026
2. **Endocrinólogo** — llevar historial completo + todos los labs

Documentos para el endocrinólogo

- TAC feb/2026 (mioma 87mm)
- Labs ene/2026 (FSH 1.0, TSH 1.34, creatinina 0.91)
- Labs jun/2026 (panel completo con HOMA-IR)

- Fórmula médica Dra. Mejía jun/2026
- InBody 270 del 09/06/2026

Preguntas clave para el endocrinólogo

1. HOMA-IR 0.91 descarta resistencia insulínica — ¿cuál es la vía hormonal de los miomas? Pedir **estradiol + progesterona en día 21 del ciclo**
2. Vitamina D 27.75 con fibromas activos — ¿qué dosis de D3 para llegar a 60–80 ng/mL?
3. B12 195.4 siendo vegana — ¿metilcobalamina sublingual o inyectable adicional?
4. **Anti-TPO** para descartar Hashimoto autoinmune
5. ¿El fibroma de 87mm tiene componente hormonal tratable sin cirugía?

Labs pendientes próximo mes

Anti-TPO | Estradiol + Progesterona día 21 | Zinc | Folato | Homocisteína | HbA1c

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA — 15 de junio de 2026

Análisis de viabilidad de distintas actividades con base en historial de rodillas (lateralización bilateral de rótulas, espinas tibiales agudizadas, antecedente bursitis patelar izquierda) y columna (escoliosis postural leve, lumbago).

Actividad	Rodillas	Columna	Veredicto
Salto de cuerda	■ Alto riesgo	■ Moderado	No recomendado
Capoeira	■ Alto riesgo (ginga constante en rodilla semiflexionada)	■ Moderado	No recomendado
Hapkido	■ Moderado (patadas, caídas, locks)	■ Moderado	No recomendado
Vóley de playa	■ Moderado (arena amortigua, saltos intermitentes)	■ Bajo	Viable con precaución
Baile afro	■ Bajo (pie plano, movimiento fluido)	■ Bajo	Recomendado

Decisión: Baile afro en Danse Academy, Medellín

Por qué es la mejor opción para este historial:

- Movimiento en pies planos o talón-planta — sin impacto explosivo sobre la rótula
- Movilidad activa de pelvis y columna lumbar/dorsal — beneficia la escoliosis postural
- Regulación del sistema nervioso vía ritmo y cuerpo — alineado con indicación de fisiatra y terapeuta
- Componente social y cultural

Indicación antes de empezar:

Avisar al instructor que hay lateralización bilateral de rótulas — solicitar modificación de zapateados fuertes o movimientos de impacto.

12 de junio — Endocrinología Dra. Claudia Yesenia Monsalve Arango (Clínica Las Américas Auna)

Primera consulta con endocrinología — motivo: manejo del peso. Historia clínica firmada y entregada el 20 de junio.

Eunice consultó por el aumento de peso (de 75 kg habitual a 82 kg en el último año, sin cambios atribuibles en la dieta). La endocrinóloga **validó el veganismo** (mejoría en energía e inflamación) y **no pidió cambiar la dieta**, sino ajustar la suplencia porque "los suplementos no son suficientes". Consideró la Vitamina D 27.7 y la ferritina como "normales" (criterio convencional, no funcional).

Diagnósticos confirmados (CIE-10):

1. **R635 Aumento anormal de peso** (principal)
2. **R53X Malestar y fatiga**
3. **L659 Pérdida no cicatricial del pelo**

4. **E539 Deficiencia de vitamina B (B12)**
5. **E559 Deficiencia de vitamina D**
6. **D259 Leiomioma del útero (miomas)**
7. M545 Lumbago

Signos vitales: PA 110/70 · Pulso 54/min · Peso 83.5 kg · Talla 172 cm · IMC 28.2

Fórmula médica (20/06/2026):

#	Medicamento	Dosis	Vía	Frecuencia	Duración
1	Bedoyecta (hidroxicobalamina/B1/B6 10000mcg)	1 ampolla	IM	cada semana	3 semanas
2	Metilcobalamina sublingual 5000mcg	1 tableta	Oral	cada día	180 días (transición: 2 tabs de 2500mcg hasta acabar tarro)
3	Vitamina D/K 2000 UI	2 cápsulas (=4000 UI, subió de 1 a 2)	Oral	cada día	180 días
4	Proteína vegana	1 scoop	Oral	cada día	180 días

Referencias entregadas:

- Nutricionista vegana especializada: **Katherine Giraldo / Salva Comunidad** (ED Forum cons. 314, 315-7921584)
- Ginecólogo: **Dr. Julián Paniagua** (Clínica Eva / Colpodiagnóstico, Torre Médica Oviedo cons. 673, 311-4460554) — para considerar **embolización** del mioma
- **Osteodensitometría + composición corporal (DEXA)**

12 laboratorios ordenados para control del 10 de julio:

Hemograma · TSH ultrasensible · Creatinina · TGO/TGP (hígado) · Colesterol total · HDL · Triglicéridos · **Curva de glucosa (pre y post carga)** · **HbA1c** · **IGF-1 (Somatomedina C)** · **Cortisol libre en orina 24h** · DEXA.

Nota clínica: el cortisol en orina 24h apunta directamente a la hipótesis raíz (estrés crónico/autonómico → cortisol → grasa visceral). La endocrinóloga **NO ordenó estradiol+progesterona día 21 ni Anti-TPO** — derivó el tema del mioma a ginecología en vez de investigar la dominancia estrogénica. Esa pregunta queda abierta.

20–21 de junio — Decisiones de Eunice sobre el plan

- ■ **No irá a ginecología (Dr. Paniagua) ni a embolización** → manejará el mioma con **Reiki**.
- ■ **No irá a la nutrióloga** → considera que se alimenta bien.
- ■ **Sí se hará los 12 exámenes** ordenados (información neutra, válida para cualquier especialista).
- ■ **Buscará otro endocrinólogo** — no le gustó el servicio de la Clínica Las Américas Auna ni de la Dra. Monsalve.
- La **eco de control del mioma** (sin imagen desde el TAC de feb/2026, 87mm) queda nombrada y a su decisión — es un dato de tamaño que acompaña el trabajo energético, no lo contradice.

Estado de acciones — semana del 15 al 21 de junio

- **Rompió el ayuno intermitente** desde el lunes 15-jun con **smoothie + proteína Pura Prote** (limpia).
- Tomando **doble dosis** de B12 y Vitamina D+K restantes (alineado con la transición de la fórmula); pidió tarro nuevo de B12.
- ■ **Bedoyecta (B12 IM)** — **dosis 1 de 3 puesta el 21-jun**. Dosis 2 ~28-jun, dosis 3 ~5-jul. (La Vitamina D es solo oral; no hay D inyectada — sin riesgo de sobredosis.)
- **Ozono IV (autohemoterapia): sesión 1 de 5, semanales**. Termina la semana del 13-jul. Avisar de mioma activo a quien aplica.
- **Sesiones de queloides en pecho: cada 15 días** (muy dolorosas). 2ª sesión el **1 de julio**.
- **Tratamiento para el cabello** — Dr. Miguel Cano (@drmiguelcano): inicia el **miércoles 24 de junio**.

Calendario de tratamientos (desde 21 de junio de 2026)

Fecha	Tratamiento
Mié 24-jun	Inicio tratamiento cabello — Dr. Miguel Cano
Sáb 28-jun	Bedoyecta (B12 IM) — dosis 2 de 3
Mar 1-jul	Queloides pecho — sesión 2 (cada 15 días)
~5-jul	Bedoyecta — dosis 3 de 3
10-jul	Control endocrino + 12 labs + DEXA
Semana del 13-jul	Fin del ozono IV (sesión 5 de 5)
Post 10-jul	Decidir suero metabólico según resultados

Evaluando — Suero metabólico (sueroterapia biorreguladora)

Producto IV homeopático/biorregulación para "sobrepeso, obesidad, dislipidemia, adiposis". Componentes: Fusobes + oligoelementos. Marcas: **LHA** (Colombia, \$190.000 c/u con 30% OFF) y **HEEL** (Alemania, \$400.000 c/u). Esquema para enfermedad de base: **mínimo 6 sueros, 1 cada 15 días** (~\$1.14M a \$2.4M COP total).

Eunice quiere hacerlo después de terminar el ozono.

***Recomendación:** la secuencia post-ozono es correcta (no stackear protocolos IV). Pero conviene **esperar los labs del 10-jul** (cortisol 24h, curva de glucosa, HbA1c, IGF-1) antes de decidir. El HOMA-IR 0.91 ya descarta resistencia insulínica y la tiroides es normal → el driver del peso parece **autonómico/cortisol, no metabólico clásico**. Un suero diseñado para "disfunción metabólica" le hablaría al órgano equivocado. Los claims de marketing ("20x más potente", "10kg en 2 meses") atribuyen al suero resultados que vienen de la dieta+ejercicio. Que los labs decidan.*

PRÓXIMOS PASOS (actualizado 21 de junio de 2026)

1. **Agendar los 12 labs + DEXA** con tiempo — la curva de glucosa y el cortisol en orina 24h requieren preparación específica.
2. **Continuar Bedoyecta** (dosis 2 ~28-jun, dosis 3 ~5-jul) + suplencia oral según fórmula.
3. **Terminar ozono** (faltan 4) y **exosomas** (faltan 3) — avisar del mioma activo en cada aplicación.
4. **Buscar nuevo endocrinólogo** y llevar este historial + resultados del 10-jul.
5. **Decidir suero metabólico** solo después de ver los labs del 10-jul.
6. Mioma: manejo con **Reiki**; eco de control disponible si en algún momento quiere el dato de tamaño.